

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CUESTIONARIO CAGE (DETECCIÓN DE ALCOHOLISMO)

CAGE Questionnaire (Ewing, 1984) · Adaptación y Validación en España (Rodríguez-Martos et al., 1986)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Cuestionario CAGE para la Detección del Trastorno por Uso de Alcohol (CAGE Questionnaire)
Sigla / Acrónimo	CAGE (acrónimo mnemotécnico en inglés: Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener)
Autoría original	John A. Ewing (1984, JAMA; concebido originalmente en 1968)
Adaptación en español	A. Rodríguez-Martos, J. Navarro, P. Vecino & R. Pérez (1986, Med Clin); Bobes et al. (2004)
Constructo evaluado	Cribado ultrarrápido de dependencia alcohólica y consecuencias psicofísicas del consumo crónico
Población diana	Adolescentes y adultos en atención primaria, urgencias hospitalarias, cirugía y medicina preventiva
Tiempo de aplicación	1 a 2 minutos (administrado verbalmente en la entrevista o autoadministrado)
Estructura y formato	4 preguntas dicotómicas (Sí / No) de formulación clínica directa no culpabilizadora
Condiciones de uso	Dominio público; libre para uso asistencial e investigación académica citando a Ewing (1984)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El alcoholismo es una enfermedad crónica y recidivante que cursa frecuentemente con un potente mecanismo defensivo de negación psicológica y minimización sistemática de las cantidades ingeridas. Las preguntas directas sobre el número exacto de bebidas al día suelen provocar respuestas evasivas o falsos negativos deliberados.

Ewing diseñó el CAGE basándose en el principio clinimétrico de explorar las **consecuencias vitales y emocionales** del beber más que las cantidades consumidas. Cada una de las cuatro letras del acrónimo explora una dimensión patognomónica de dependencia: la pérdida de control y necesidad de reducir (Cut down), el conflicto social y la molestia ante críticas ajenas (Annoyed), el remordimiento moral (Guilty), y la presencia de tolerancia neurobiológica con síndrome de abstinencia matutino (Eye-opener).

3. LAS 4 PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO CAGE

Letra	Pregunta Clínica Estructurada	Respuesta	Signo Clínico Evaluado
C	¿Ha sentido alguna vez la necesidad de cortar o disminuir el consumo de bebidas alcohólicas?	Sí = 1 / No = 0	Pérdida de control del consumo (Cut down)
A	¿Le ha molestado que la gente critique su forma de beber?	Sí = 1 / No = 0	Conflicto social e irritabilidad (Annoyed)
G	¿Se ha sentido alguna vez culpable o mal por su forma de beber?	Sí = 1 / No = 0	Remordimiento y culpa moral (Guilty)
E	¿Alguna vez ha tomado un trago a primera hora de la mañana para calmar los nervios o la resaca?	Sí = 1 / No = 0	Abstinencia matutina física (Eye-opener)

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN HOSPITALES Y ATENCIÓN PRIMARIA

Sensibilidad clínica	Sensibilidad del 76 — 88% para la detección de dependencia alcohólica y consumo perjudicial según criterios DSM-IV/5 en España (Rodríguez-Martos et al., 1986).
Especificidad diagnóstica	Elevada especificidad (85 — 95%); cuando un sujeto responde afirmativamente a ≥ 2 preguntas, la probabilidad de alcoholismo real es muy elevada.
Valor predictivo positivo	VPP del 78 — 83% en salas médicas hospitalarias y servicios de traumatología/urgencias.
Sensibilidad del ítem E	El ítem “Eye-opener” de forma aislada tiene una especificidad del 98% para el diagnóstico de dependencia física establecida con neuroadaptación.
Validez concurrente	Correlación positiva muy alta con el cuestionario AUDIT ($r = 0.74$), con los niveles séricos de gamma-glutamilttransferasa (GGT, $r = 0.56$) y volumen corpuscular medio (VCM).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Calificación dicotómica	Cada respuesta afirmativa (“Sí”) suma 1 punto . Cada “No” suma 0 puntos .
Puntuación directa total	Suma aritmética directa de las 4 preguntas. Rango teórico posible: 0 a 4 puntos .
Modo de administración	Las preguntas deben intercalarse de forma natural en la anamnesis general de hábitos de vida (tras preguntar por tabaco, ejercicio o alimentación), evitando el tono de confrontación.
Temporalidad evaluada	Explora tanto la conducta actual como antecedentes vitales significativos de consumo descontrolado.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación CAGE	Probabilidad	Clasificación	Significación Clínica y Conducta
0 puntos	< 5%	Consumo No Problemático	Bajo riesgo de problemas relacionados con el alcohol.
1 punto	25 - 35%	Sospecha Leve / Riesgo	Consumo de riesgo potencial; aconsejar moderación y revisar consumo.
2 puntos	75 - 80%	Cribado Positivo (Consumo Perjudicial)	Alta probabilidad de abuso o dependencia; requiere intervención breve.
3 - 4 puntos	> 95%	Dependencia Alcohólica Grave	Casi certeza de Síndrome de Dependencia; alto riesgo de abstinencia física.

PUNTOS DE CORTE DIAGNÓSTICOS CANÓNICOS (EWING):

- **Puntuación ≥ 2 puntos:** Define el resultado **Positivo** para problemas con el alcohol en la práctica médica internacional (sensibilidad 85%, especificidad 89%).
- **Positividad en el Ítem E (Consumo Matutino):** Aun con total = 1, la presencia de necesidad de beber por la mañana para calmar temblores es signo inequívoco de neuroadaptación y dependencia física severa.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA

Paso 1: Aplicación del CAGE: Formular las 4 preguntas ante sospecha clínica, traumatismos reiterados o analítica con GGT/VCM elevados.

Paso 2: Si Puntuación = 0: Reforzar hábitos saludables de consumo nulo o moderado.

Paso 3: Si Puntuación = 1: Realizar intervención motivacional breve (informar sobre Unidades de Bebida Estándar - UBEs; límite seguro < 10 UBEs/semana en mujeres y < 20 UBEs/semana en varones).

Paso 4: Si Puntuación ≥ 2 (Cribado Positivo):

- Evaluar complicaciones somáticas (hepatopatía, esteatosis, polineuropatía, pancreatitis).
- Descartar riesgo de abstinencia alcohólica complicada (**Delirium Tremens** o crisis comiciales si cesa bruscamente el consumo).
- Si se planifica deshabituación ambulatoria: pauta descendente de benzodiazepinas de semivida larga (diazepam) más tiamina parenteral/oral preventiva de Wernicke; derivar a Centro de Atención a las Adicciones (CAD / UCA).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN MEDICINA INTERNA

Identificación: Varón de 52 años, pintor de brocha gorda, ingresado en traumatología tras fractura de fémur al caerse de un andamio. En planta se muestra irritable, sudoroso y con temblor fino de manos a las 24 horas del ingreso.

Evaluación CAGE:

- C (Cut down): Sí = 1 ("Mi mujer me dice siempre que lo deje").
- A (Annoyed): Sí = 1 ("Me da rabia que me controlen las cervezas").
- G (Guilty): Sí = 1 ("A veces me arrepiento de gastar el sueldo en el bar").
- E (Eye-opener): Sí = 1 ("Antes de empezar la obra me tomo dos carajillos de orujo para asentar el pulso").

Puntuación Total CAGE = 4 / 4 (Dependencia Alcohólica Severa con Neuroadaptación).

Alerta de Seguridad Inmediata: Riesgo crítico inminente de **Delirium Tremens** postraumático/quirúrgico.

Manejo Terapéutico: Se pautó clordiazepóxido oral según protocolo CIWA-Ar, tiamina 300 mg/día IM (complejo B) y fluidoterapia con control electrolítico. El paciente superó el postoperatorio sin desorientación ni convulsiones y fue derivado al alta a la Unidad de Conductas Adictivas.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Urgencias Médicas:

- **Encefalopatía de Wernicke:** Confusión, oftalmoplejía y ataxia tras cese de alcohol; administrar tiamina parenteral urgente antes de cualquier suero glucosado.
- **Delirium Tremens:** Alucinaciones liliiputienses, temblores masivos y agitación psicomotora con mortalidad del 5 – 10% si no se trata.

Diagnóstico Diferencial:

- **Consumo Social vs. Dependencia:** El CAGE detecta problemas conductuales y dependencia, no consumo social festivo esporádico.
- **Depresión Mayor Primaria:** Muchos pacientes beben como automedicación de un cuadro afectivo severo subyacente.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Ewing, J. A. (1984). Detecting alcoholism: The CAGE questionnaire. *JAMA*, 252(14), 1905-1907. <https://doi.org/10.1001/jama.1984.03350140051025>
- Rodríguez-Martos, A., Navarro, R., Vecino, C., & Pérez, R. (1986). Validación de los cuestionarios KFA y CAGE para el diagnóstico de alcoholismo en el medio hospitalario. *Medicina Clínica*, 86(14), 621-625.
- Mayfield, D., McLeod, G., & Hall, P. (1974). The CAGE questionnaire: validation of a new alcoholism screening instrument. *The American Journal of Psychiatry*, 131(10), 1121-1123.
- Dhalla, S., & Kopec, J. A. (2007). The CAGE questionnaire for alcohol misuse: a review of reliability and validity studies. *Clinical and Investigative Medicine*, 30(1), 33-41.